

PAUSE CARDIO

Nouveautés de la semaine du 23 août 2026

5 nouveautés cette semaine, dont 2 susceptibles de changer votre pratique.

RYTHMOLOGIE **Changement de pratique** Essai randomisé · AVANT-GUARD

Pulsed Field Ablation as Initial Therapy for Persistent Atrial Fibrillation

NEJM · mai 2026 · présenté à l'ACC.26

Premier essai randomisé comparant l'ablation par champ pulsé (PFA) d'emblée au traitement anti-arythmique en première intention chez des patients en FA persistante non encore traités : la stratégie invasive précoce sort gagnante.

Au cabinet : chez un patient symptomatique en FA persistante récente, l'adressage précoce en rythmologie pour ablation devient une option de première ligne à discuter, sans passage obligé par l'anti-arythmique.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

RYTHMOLOGIE **Changement de pratique** Essai randomisé · CHAMPION-AF

Left Atrial Appendage Closure or Anticoagulation for Atrial Fibrillation

NEJM · mars 2026 · présenté à l'ACC.26

3 000 patients en FA éligibles aux AOD randomisés fermeture d'auricule (Watchman FLX) vs AOD, suivis 3 ans. Non-infériorité atteinte sur le critère décès CV/AVC/embolie (5,7 % vs 4,8 %) et hémorragies non procédurales réduites (10,9 % vs 19,0 %), mais davantage d'AVC ischémiques dans le bras dispositif (3,2 % vs 2,2 %).

Au cabinet : Les patients demanderont la « fermeture pour arrêter les anticoagulants » : savoir présenter le compromis (moins de saignements, plus d'AVC ischémiques) et réserver la fermeture aux vraies contre-indications aux AOD.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

RYTHMOLOGIE **À connaître** Essai randomisé · CORNERSTONE AF

Adjunctive posterior wall isolation for persistent and long-standing persistent atrial fibrillation: the CORNERSTONE AF trial

European Heart Journal · juin 2026 · présenté à l'EHRA 2026

Essai multicentrique randomisé en FA persistante (première ablation) : l'ajout de l'isolation de la paroi postérieure à l'isolation des veines pulmonaires n'apporte pas de bénéfice sur la récurrence d'arythmie atriale, confirmant CAPLA.

Au cabinet : Pour la FA persistante adressée à une première ablation, l'isolation des veines pulmonaires seule reste la stratégie de référence.

[Article original](#)

Subcutaneous Defibrillator Implantation With or Without Defibrillation Test: The Primary Results of the Randomized PRAETORIAN-DFT Trial

Circulation · avril 2026 · présenté à HRS 2026

965 patients implantés d'un défibrillateur sous-cutané : l'implantation sans test de défibrillation, guidée par le score PRAETORIAN, est non inférieure sur l'échec du premier choc pour arythmie ventriculaire spontanée, avec mortalité comparable.

Au cabinet : Chez le candidat au défibrillateur sous-cutané, l'omission du test de défibrillation devient la norme si l'imagerie est favorable — procédure simplifiée à expliquer au patient.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

2026 HRS/EHRA scientific statement on pulsed field ablation for cardiac arrhythmias

Heart Rhythm · février 2026

Premier document de consensus HRS/EHRA dédié à l'ablation par champ pulsé : mécanismes, efficacité et sécurité comparées aux énergies thermiques, applications au-delà de la FA, formation des opérateurs et lacunes de connaissances — au moment où la PFA devient l'énergie dominante en ablation de FA.

Au cabinet : Référence à connaître pour répondre aux questions des patients adressés en ablation par champ pulsé (bénéfices, risques spécifiques, place par rapport aux techniques thermiques).

[Article original](#) · [Analyse](#)

Tableau de bord complet — toutes les sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture : hacuubo.github.io/veille-cardio

Fiches rédigées par Claude — à valider par le lecteur avant toute application clinique.